



SAISINE

PASSAGE EN CATÉGORIE B — Corps des ambulanciers de la Fonction Publique Hospitalière

Intersyndicale CGT — SUD Santé Sociaux · CHU de Toulouse · Version mise à jour le 30 juin 2026

Intersyndicale CGT — SUD Santé Sociaux

Ambulanciers de la Fonction Publique Hospitalière

CHU de Toulouse — Service Transport Patients

Place du Docteur Baylac, TSA 40031 — 31059 Toulouse Cedex 9

Adressée à Madame Stéphanie RIST,
Ministre de la Santé, des Familles,
de l'Autonomie et des Personnes handicapées,
et à Monsieur le Directeur général de l'offre de soins
(DGOS),
14 avenue Duquesne,
75007 Paris.

Fait à Toulouse, le 30 juin 2026

Objet et destinataires

Objet : Demande de révision du classement statutaire du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière — passage de la catégorie C à la catégorie B.

Réf. : Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 · Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021
· Arrêté du 11 avril 2022 modifié le 4 juillet 2024 · Art. L. 4393-1 et R. 6311-17 CSP.

Copies : DGAFP · HCPP · CSFPH · FHF · Fédérations nationales CGT Santé & SUD Santé
Sociaux · Direction Générale CHU de Toulouse

Madame la Ministre, Monsieur le Directeur général,

Les organisations syndicales CGT et SUD Santé Sociaux, représentant les ambulanciers de la fonction publique hospitalière (FPH) au CHU de Toulouse, ont l'honneur de vous soumettre la présente saisine aux fins d'obtenir la révision du classement statutaire du corps des ambulanciers hospitaliers, actuellement maintenu en catégorie C en application du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, en vue de son passage en catégorie B.

Cette demande n'est pas une revendication salariale isolée : elle est la conséquence logique et documentée d'une triple réalité — un référentiel de formation dépassé par les missions exercées, un précédent statutaire créant une iniquité de traitement entre corps comparables, et un risque professionnel cumulatif objectivé par huit sources institutionnelles nationales.

I. Contexte réglementaire et situation actuelle

1.1 Un rattachement à la filière soignante sans révision catégorielle

Le décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 a procédé à l'intégration des ambulanciers hospitaliers dans la filière soignante de la FPH. Il reconnaît formellement le caractère soignant de leurs missions (articles L. 4393-1 et R. 6311-17 CSP) mais maintient le corps en catégorie C, créant une contradiction manifeste entre reconnaissance de principe et positionnement indiciaire.

1.2 L'iniquité de traitement avec les aides-soignants — précédent Ségur

Le corps des aides-soignants et auxiliaires de puériculture, titulaire d'un diplôme de niveau 4 RNCP, a été reclassé en catégorie B par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021. Les ambulanciers, dont le DEA est identiquement enregistré au niveau 4 du RNCP, n'ont bénéficié d'aucune mesure équivalente.

Argument-clé

Le groupe de travail ministériel sur la VAE du 7 novembre 2025 a officiellement reconnu que le niveau de compétences exigé pour le DEA « relève sans conteste de la catégorie B de la fonction publique ».

1.3 Un mouvement social révélateur d'une tension structurelle nationale

Le mouvement de grève engagé au CHU de Toulouse depuis le 7 juin 2026 s'inscrit dans une série de mobilisations inter-CHU documentées : Angers (2021), Tours (2021-2024), Lyon (2022-2024), Marseille (2023-2024).

II. Sept arguments précis et recevables

Argument 1 — Un référentiel de formation structurellement dépassé par les missions exercées

Le référentiel du DEA (arrêté du 11 avril 2022 modifié le 4 juillet 2024) structure la formation en cinq blocs centrés sur la prise en soin générale, le recueil de données cliniques, le transport et l'entretien du véhicule. Il ne couvre pas, ou de façon notoirement insuffisante, les missions suivantes :

- Transports sous contrainte psychiatrique (3 751 missions en 2025 au CHU de Toulouse), transferts UMD/USIP, réintégrations après fugue ;
- Transports pénitentiaires sécurisés (UHSI, UHSA), transferts vers le juge des libertés et de la détention ;

- Transports de patients à risque clinique élevé : soins palliatifs, médecine nucléaire, médecine infectieuse, aplasie médullaire, sorties de bloc/réanimation, patients greffés — manipulation de dispositifs invasifs sans formation dédiée ;
- Transports mortuaires nocturnes, avec gestion relationnelle des familles en détresse ;
- Transports de produits sanguins labiles (PSL) — CHU de Caen Normandie — sans cadre de formation reconnu, hors exigences de la chaîne du froid (arrêté du 10 septembre 2007) ;
- **Transports pédiatriques et néonataux spécialisés et prises en soin bariatriques**
- exemple du CHU de Montpellier : transports de couveuses pédiatriques avec l'équipe du SMUR pédiatrique, exigeant une vigilance spécifique (posologie pondérale, gestion de voies aériennes de petit diamètre, prévention de l'hypothermie du nourrisson, accompagnement psychologique de l'enfant et des parents en situation de stress lors d'un transfert vers un bloc opératoire) ; et prises en soin bariatriques nécessitant un équipement spécifique adapté aux patients en surpoids ou lourdement appareillés. Le bloc 2 du DEA (GSU2) reste un socle généraliste qui ne couvre ni l'un ni l'autre de ces champs. La FAE pédiatrique, bien que fortement recommandée, demeure une formation optionnelle, non certifiante et hors RNCP, accessible de façon inégale selon les établissements ;
- Participation aux Plans Blancs et à la médecine de catastrophe, y compris en remplacement partiel des équipes SAMU.

Argument-clé

Un agent qui exerce des missions non couvertes par son référentiel de formation initiale engage sa responsabilité personnelle sans cadre de compétence reconnu. C'est un argument de sécurité patient et de protection de l'agent que la Direction ne peut éluder sans fragiliser sa propre fiche de poste — l'extension aux transports pédiatriques et bariatriques (CHU de Montpellier) confirme que cet écart concerne l'ensemble des CHU, et non un établissement isolé.

CHU de Toulouse, données d'activité Transport Patients 2025 : 56 843 transports patients au total, dont 3 751 transports psychiatriques sous contrainte et 4 033 transports urgences. — Constat intersyndicale CHU de Caen Normandie 2026. — Constat intersyndicale CHU de Montpellier 2026 : transports de couveuses pédiatriques et prises en soin bariatriques hors cadre certifiant. — Arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux bonnes pratiques transfusionnelles.

Argument 2 — Le précédent Ségur — iniquité de traitement objectivée entre corps de niveau équivalent

Critère	Aides-soignants (AS)	Ambulanciers FPH
Diplôme	DEAS — Niveau 4 RNCP	DEA — Niveau 4 RNCP
Durée de formation	~1 400 h (réforme 2021)	~800 h + FAE SMUR optionnelle 175 h, hors RNCP
Filière FPH	Soignante	Soignante en droit (décret 2022-1658), maintien de fait technique/logistique dans de nombreux CHU
Catégorie	B depuis le 1er octobre 2021	C maintenue à ce jour

La comparaison est factuelle : deux corps de diplôme d'État de même niveau RNCP, soumis à un élargissement comparable de leurs actes autorisés — l'un reclassé en 2021 au titre du Ségur, l'autre maintenu en catégorie C sans explication documentée.

Argument 3 — Le déficit de formation : l'angle d'attaque le plus difficile à réfuter

Le dossier AFASH (version 02/2026) documente 12 compétences spécifiques exercées par l'ambulancier SMUR sans cadre de formation ni reconnaissance RNCP, et recense 24 missions sur 32 hors périmètre DEA/décret n° 2022-629 (soit les trois quarts). La France est le seul grand pays à ne disposer d'aucun positionnement RNCP spécifique pour l'ambulancier spécialisé en urgence préhospitalière (Royaume-Uni : HCPC ; Allemagne : Notfallsanitäter, 3 ans ; Québec : diplôme national ; États-Unis : NREMT).

Argument 4 — Un risque professionnel cumulatif objectivé par huit sources institutionnelles

Les données issues de huit organismes institutionnels indépendants (DARES, France Travail, ONVS, CNAM, INRS, ANACT, FNTS, FHF/ANAP) convergent pour documenter la pénibilité et les risques cumulatifs du métier. Accidentologie 2,5× supérieure à la moyenne des professions de santé (Sécurité Routière 2023) ; 57 à 93 % des ambulanciers victimes de violence sur carrière (rapport sécurité professionnels de santé 2025).

Argument 5 — L'incidence directe du Plan « Zéro contention 2030 » sur le risque en transport

Annoncé le 2 juin 2026, l'objectif national « zéro contention » en psychiatrie à l'horizon 2030 déplace mécaniquement une partie du risque comportemental vers la phase de transport, sans qu'aucun des leviers annoncés (cartographie, formation à la désescalade, espaces d'apaisement) ne vise à ce stade les professionnels du transport sanitaire.

Argument 6 — Privatisation croissante et argument économique recevable par le DGOS

Le coût annuel d'un passage en catégorie B pour 50 ambulanciers (150 000 à 200 000 €) est inférieur au seul surcoût de l'intérim pour 20 % des postes (90 000–150 000 €) et très largement inférieur au coût cumulé intérim + turnover 18 % (135 000–360 000 €) + grèves répétées + externalisation.

Argument 7 — Sinistralité routière, abandon de protection institutionnelle et coût humain

Le témoignage d'une ambulancière du CHG Marchant (Toulouse), victime d'une agression routière en juillet 2017, abandonnée par sa direction faute de suite pénale, contrainte de financer elle-même sa défense juridique (gain de cause mi-2024), 10 mois d'arrêt de travail et séquelles psychologiques durables, illustre un mécanisme systémique d'abandon de protection sociale et de précarité indiciaire empêchant l'accès à la défense juridique.

III. Proposition opérationnelle — Module de compétences complémentaire au DEA (MHS)

Module Missions Hospitalières Spécifiques (MHS), sur le modèle de la formation d'adaptation à l'emploi des ambulanciers SMUR (arrêté du 17 mai 2023) — format déjà validé réglementairement, immédiatement crédible auprès des ARS et des CESU.

N°	Module	Contenu et justification
M1	Contrainte et agressivité	Cadre légal de la contrainte psychiatrique, désescalade sans contention mécanique (trajectoire zéro contention 2030), transferts UMD/USIP, gestion de l'agressivité. 3 751 transports sous contrainte en 2025.
M2	Transports sécurisés et pénitentiaires	Conduite sous escorte, protocoles IRIS, coordination pénitentiaire ; transferts UHSI, UHSA. Modèle CHU de Lyon.
M3	Patients fragiles, risque infectieux élevé, pédiatrie et bariatrie	Radioprotection et fin de vie (soins palliatifs, médecine nucléaire) ; asepsie renforcée (médecine infectieuse, aplasie médullaire) ; surveillance et dispositifs invasifs (sorties de bloc/réanimation, greffés) ; transport pédiatrique et néonatal spécialisé avec équipe SMUR pédiatrique (posologie pondérale, voies aériennes de petit diamètre, prévention de l'hypothermie, accompagnement psychologique de l'enfant et des parents) ; prises en soin bariatriques avec équipement adapté. [Extension pédiatrie/bariatrie — NOUVEAU 30/06/2026, exemple CHU de Montpellier]
M4	Transports mortuaires	Cadre réglementaire, posture relationnelle, protocoles de sécurité pour interventions isolées hors heures ouvrables.
M5	Médecine de catastrophe et Plan Blanc	Organisation de la chaîne médicale des secours, équivalence partielle FAE SMUR, intégration aux Plans Blancs.
M6	Maintenance de premier niveau	Contrôles et dépannage simples avec outillage fourni. Condition syndicale préalable à toute inscription en fiche de poste.
M7	Spécificités SMUR	Assistance gestes de réanimation, damage control préhospitalier, gestion de scène, NRBC, SSE, coordination interservices, brancardage HéliSMUR. Dossier AFASH 02/2026.

La France est le seul grand pays européen à ne pas reconnaître statutairement ses ambulanciers SMUR ni de filière pédiatrique/bariatrique dédiée. Royaume-Uni (HCPC), Allemagne (Notfallsanitäter, 3 ans), Québec (diplôme national), États-Unis (NREMT).

IV. Demandes formelles

- Ouverture d'une concertation formelle avec la DGOS, la DGAFP et le CSFPH en vue d'une révision du décret n° 2022-1658, aux fins de reclassement en catégorie B ;
- Inscription de cette révision statutaire à l'ordre du jour d'une prochaine instance de dialogue social national de la FPH ;
- Saisine du Haut Conseil des professions paramédicales (HCPP) pour intégrer le Module MHS — incluant le volet pédiatrique et bariatrique du module M3 — au référentiel du DEA, sur le modèle de la FAE SMUR ;
- Intégration explicite des ambulanciers de la FPH au volet formation du Plan « Zéro contention 2030 » ;
- Reconnaissance de la FAE pédiatrique comme module certifiant intégré au RNCP, et création d'un module bariatrique dédié, sur le modèle de l'expérience du CHU de

Montpellier ;

- Entretien avec les représentants des organisations syndicales signataires afin d'examiner les modalités d'un calendrier de mise en œuvre.

V. Références juridiques et réglementaires

Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 · Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 · Arrêté du 11 avril 2022 modifié le 4 juillet 2024 · Arrêté du 17 mai 2023 (FAE SMUR) · Articles L. 4393-1 et R. 6311-17 CSP · Annonce ministérielle Plan « Zéro contention 2030 » du 2 juin 2026 · Groupe de travail ministériel VAE du 7 novembre 2025 · Arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux bonnes pratiques transfusionnelles.

Pièce jointe — Synthèse exécutive

Argument	Fait clé	Source
Iniquité statutaire	AS (niveau 4 RNCP) → catégorie B en 2021. Ambulanciers (niveau 4 RNCP) → catégorie C maintenue.	Décrets 2021-1257 / 2022-1658
Référentiel dépassé	3 751 transports sous contrainte non couverts. Transports PSL (Caen). Transports pédiatriques et bariatriques (Montpellier) hors cadre certifiant.	Données CHU Toulouse 2025 · Constats Caen et Montpellier 2026
Tension RH nationale	4 490 postes à pourvoir · 78 % d'entreprises en difficulté · turnover 18 %.	BMO France Travail 2026 · FNTS 2024
Risque violence et accidentologie	90 victimes ambulancières (ONVS 2023) · accidentologie 2,5× supérieure à la moyenne des professions de santé.	ONVS 2025 · Sécurité Routière 2023
Privatisation & économie	Coût passage en B (50 agents) : 150-200 k€ < surcoût intérim (90-150 k€) + turnover 18 % (135-360 k€/an).	FHF/ANAP · Hoppi 2026
Sinistralité & abandon institutionnel	Témoignage CHG Marchant : agression 2017, 10 mois AT, abandon direction, gain de cause mi-2024.	Témoignage juin 2026

Module MHS — 7 modules : M1 Contrainte/agressivité · M2 Transports pénitentiaires · M3 Patients fragiles, pédiatrie et bariatrie · M4 Transports mortuaires · M5 Plan Blanc · M6 Maintenance · M7 SMUR.

Fait à Toulouse, le 30 juin 2026

Pour la CGT : Julien TERRE · Sébastien GOUSSY

Pour SUD Santé Sociaux : Victor ALAVA

Représentants du personnel ambulancier : Laurent BEZIA · Jérôme JEAN-CHARLES